Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Comarca de Campo Grande
4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública

TERMO DE CONCLUSÃO
Em / /2024, estes autos foram conclusos ao MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública desta Comarca de Campo Grande - MS.

Escrivão/Analista

Autos n.º 0821845-74.2021.8.12.0110.
Autor(a): Constância Sales Gonçalves
Ré(u): Estado de Mato Grosso do Sul
Ação: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Vistos...

1. Constância Sales Gonçalves deduziu AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER contra Estado de Mato Grosso do Sul, já qualificados, alegando, em síntese, que possui doença de certa gravidade e que lhe foi prescrito pelo médico que lhe assiste a utilização de medicamento(s) descrito(s) na inicial, aduzindo, outrossim, que é obrigação do ente federado demandado fornecê-la, de modo que, então, requereu à parte demandada o fornecimento da aludida medicação, não tendo, até o momento, sido atendido, o que reputa indevido. Diante de tais fatos, após fundamentar sua pretensão, pediu a concessão de tutela de urgência para o fim de compelir o réu a lhe disponibilizar o tratamento pugnado e, definitivamente, a ratificação da tutela eventualmente deferida. Juntou documentos.

Após ter o Núcleo de Apoio Técnico do TJMS (NAT) emitido Parecer Técnico desfavorável dado ao medicamento solicitado não estar padronizado pelo RENAME, fora julgado extinto o processo sem resolução de mérito em virtude da necessidade de inclusão da União como polo passivo.

Então, a parte Autora interpôs Recurso Inominado, sendo que a 2ª Turma Recursal Mista entendeu por negar provimento ao recurso, cujo Acórdão fora Embargado pela parte autora em sequência, que por sua vez, foi rejeitado. E, a seguir, a parte Autora impetrou Mandado de Segurança, sendo que a 1ª Seção Cível entendeu por conceder a segurança para cassar o acórdão impugnado e assim, a sentença de extinção do feito, determinando que este Juízo procedesse à análise da liminar, e em caso de permanência do entendimento da necessidade da União, declinasse da competência em favor do Juizado Especial Federal.

Assim, após indeferir o pleito de tutela antecipada, este juízo procedeu o declínio da competência ao JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA FAZENDA PÚBLICA desta capital, que por sua vez, após fundamentar, determinou a exclusão da União do polo passivo e a devolução do processo aos autos de origem.

Citado, o Réu apresentou contestação, arguindo preliminar de incompetência e pugr

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 04/09/2024 às 19:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821845-74.2021.8.12.0110 e código kemcVp32.

em suma pela improcedência do pedido inicial.

Em impugnação a parte autora rebateu os termos da contestação e pediu pela procedência da ação informando não ter mais provas a produzir, bem como o réu em seguida também pediu pelo julgamento imediato da lide de modo que os autos, então, vieram conclusos para decisão.

É o breve relatório. DECIDO.

2. Trata-se de ação ordinária na qual, ao que consta, pretende a parte autora que a parte demandada seja obrigada a fornecer à parte autora os fármacos prescritos pelo médico que lhe atende - *"NESINA e CALDE K2"*.

No caso, é de se salientar desde logo que nos termos do art. 196 da CF/88 é dever do Estado prestar a devida assistência a saúde ao cidadão. Aliás, os princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde dos cidadãos impõe, em sendo o caso, a União, Estado e ao Município, de modo *solidário* (art. 196, da CF), a obrigação de fornecer medicamentos, insumos e tratamentos médicos em favor de pessoas carentes, que comprovem a sua necessidade e pertinência por prescrição médica. Logo, tem-se que inclusive presente a legitimidade da parte demandada para figurar no pólo passivo da lide.

Aliás, considerando que o tratamento não se mostra *padronizado* tem-se que descabido a inclusão necessária da União e encaminhamento do feito à Justiça Federal nos termos do Tema 1234/STF.

> REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REMESSA E APELO NÃO PROVIDOS. Por força do que prescreve a Constituição da República, o SUS. Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. É dever do Município e do Estado providenciar tratamento de saúde gratuitamente para pessoas hipossuficientes, consoante se depreende da regra insculpida no artigo 196 da Constituição da República. Remessa e apelo não providos.
> TJMS - Apelação nº 0900075-24.2017.8.12.0029, 1ª Câmara Cível, Rel. João Maria Lós. j. 05.10.2018.
>
> AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RESP. Nº 1.657.159 SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É solidária a responsabilidade dos entes públicos pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao cidadão escolher em face de quem proporá a ação. A saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual deverá garantir à sociedade a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...)
> TJMS - Agravo Interno nº 0802932-18.2014.8.12.0004, 4ª Câmara Cível, Rel. Odemilson Roberto Castro Fassa. j. 12.09.2018.
>
> REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. HMIB. DEVER DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR VAGA. 1. Segundo o art. 196, da CF/88: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 04/09/2024 às 19:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821845-74.2021.8.12.0110 e código kemcVp32.

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Comprovada a necessidade de o autor internar-se imediatamente em Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Materno Infantil de Brasília, sob risco de morte, é dever do Estado de providenciar a vaga, a fim de garantir o bem estar e a saúde do paciente. 4. Remessa oficial não provida.
TJDFT – 4ª Turma Cível. RMO nº 20150111022618, Rel. Arnoldo Camanho. j. 17.08.2016.

E, quanto ao mérito, tem-se que a parte autora logrou demonstrar, em linha de princípio, ser portadora de uma moléstia, entretanto, no caso em debate observa-se que descabe acolhimento da pretensão posta na inicial não se observando de forma patente irregularidade do ente estatal, recusa ou omissão na disponibilização de medicamento(s) aptos ou pertinentes a tratar de sua enfermidade.

No caso, denota-se que apontado pelo parecer do NAT que os medicamentos solicitados não se encontram padronizados na Rename, bem como se mostra *desfavorável* ao pleito, p. 43/44.

Aliás, o parecer do NAT se mostra fundamentado e de forma clara e expressa expõe razões para o não acolhimento do pedido de fornecimento de produtos não padronizados, inclusive salientado que existem *diversos* medicamentos – 29 medicamentos distribuídos em 4 tratamentos - cabíveis para tratamento da moléstia da parte autora padronizados e que podem ser disponibilizados pelo Poder Público.

IX - Sugerir medicamentos ou tratamentos similares ao requerido, preferencialmente existentes no Sistema Único de Saúde (SUS) obrigatoriamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de comprovada e equiparada eficiência ao requisitado judicialmente, com a mesma comodidade de uso e comparação de custo orçamentário;

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Diabete Melito tipo 2, Portaria SCTIE/MS nº 54 de 11//11/2020, oferece os medicamentos Cloridrato de Metformina 500 mg e 850 mg comprimido; Glibenclamida 5mg comprimido; Gliclazida 30 mg e 60 mg comprimido; Insulina NPH 100 U/mL suspensão injetável; Insulina Regular 100 U/mL solução injetável; Dapagliflozina 10 mg comprimido.

A Osteoporose tem tratamento medicamentoso oferecido pelo SUS através do PCDT da Osteoporose, regido pela Portaria SAS/MS nº 451, de 09 de junho de 2014, que oferece Carbonato de Cálcio 1250mg, Calcitriol, Carbonato de Cálcio + Colecalciferol (500mg + 400UI, 600mg + 400UI), Alendronato de Sódio, Risedronato de Sódio, Raloxifeno, Estrógenos conjugados, Calcitonina, Pamidronato Sódico.

O SUS oferece tratamento para Dor Crônica através do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Dor crônica, regido pela Portaria SAS/MS nº 1083 de 02 de outubro de 2012. Os medicamentos Ácido Acetilsalicílico, Dipirona, Paracetamol, Ibuprofeno, Amitriptilina, Nortriptilina, Clomipramina, Fenitoína, Carbamazepina, Gabapentina, Ácido Valproico, Codeína, Morfina, Metadona são oferecidos aos pacientes cadastrados.

A RENAME 2020 tem padronizado no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) medicamentos analgésicos (Dipirona, Paracetamol), anti-inflamatório (Ibuprofeno), corticoides sistêmicos (Dexametasona, Ésteres de Betametasona, Prednisona, Prednisolona), antidepressivos (Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina, Fluoxetina), anticonvulsivantes (Ácido Valproico, Carbamazepina, Fenitoína, Fenobarbital), vitaminas (Cianocobalamina, Piridoxina, Tiamina), antipsicóticos (Clorpromazina, Decanoato de Haloperidol, Haloperidol), ansiolíticos (Clonazepam, Diazepam).

Ora como resta claro dos documentos de pp. 23 se indica que a parte autora nem mesmo exauriu o uso de TODOS os medicamentos padronizados apontados para o tratamento de sua

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 04/09/2024 às 19:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821845-74.2021.8.12.0110 e código kemcVp32.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Comarca de Campo Grande
4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública

moléstia.

P. 23

9. Existe(m) remédio(s) fornecido(s) pelo SUS que não foi(ram) utilizado(s)?
( ) Sim (X) Não
Se afirmativa a resposta, qual(is)?
já usou os que são NPH 100 fornecidos e ainda em uso de Insulina + glicazida 30 mg e metformina
9.1. Quanto à(s) alternativa(s) do SUS que porventura não tenha(m) sido utilizada(s), esclareça tecnicamente porque não foi(ram) prescrita(s) ao(à) paciente:
(X) contraindicação ( ) efeitos adversos ( ) ineficácia (X) resposta terapêutica insatisfatória
( ) outro motivo: Qual:
Justificar: / GLICENCLAMIDA ESTÁ CONTRA INDICADA para a paciente

Assim, o NAT aponta '29' medicamentos para tratamento da parte autora e ao que consta não apontado que a parte teria exaurido o uso de tais opções. Aliás, ao que transparece fez e faz uso de 2 ou 3 medicamentos (item 9 de p. 23). E, se mostra importante consignar que não há indicativo documental colacionado de recusa de fornecimento dos tratamentos pelo poder público via SUS.

E, por seu turno e como dito o NAT apontou a existência de vários medicamentos atinentes ao tratamento da parte autora que são padronizados e disponibilizados pelo Ente Público, sem que houve efetiva prova que *todos* tenham sido *previamente* utilizados e que *todos* são *ineficazes* ao tratamento. E, sem tal prova como reiterada a jurisprudência do STJ (Tema 106) não cabe obrigar ao Estado a obrigação de ofertar medicamentos em exclusividade a parte autora que não são padronizados, quando nem exauriu a utilização dos padronizados.

> RECURSO NECESSÁRIO E APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS ESTADUAL E MUNICIPAL - MÉRITO - PARTE NÃO COMPROVA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO REQUERIDO, NEM QUE OS FORNECIDOS PELO SUS SÃO INEFICAZES PARA TRATAMENTO DE SUAS DOENÇAS - PRECEDENTE PARADIGMA DO STJ (TEMA 106) - REFORMA DA SENTENÇA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1) Em não sendo comprovada a indispensabilidade do medicamento pleiteado, nem que os fármacos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da moléstia do paciente já foram utilizados ou são ineficazes, não há se falar em obrigação da rede pública de saúde no fornecimento de medicamento diferenciado, não listado na relação de medicamentos do SUS. Precedente paradigma estabelecido pelo STJ, no julgamento do RESp nº 1.657.156/RJ (Tema 106). 2) Recursos Necessário e Voluntário conhecidos e providos.
> TJMS - Apelação nº 0803547-58.2017.8.12.0018, 2ª Câmara Cível, Rel. Nélio Stábile. J. 20.08.2019.

E, por sua vez, anote-se que o NAT é um órgão de cunho técnico e imparcial de modo que seu parecer merece crédito a ser observado pelo Juízo.

No mais, cabe ressaltar o já exposto pelo e. Des. Vladimir Abreu da Silva quanto ao tema (Agravo de Instrumento nº 1409120-82.2017.8.12.0000, 5ª Câmara Cível j. 15.12.2017) e sobre o indeferimento de medicamento/tratamento que não consta da relação do Rename/SUS *quando* há tratamento oferecido pelo SUS:

> "Em que pese a saúde ser direito de todos, consoante respaldo constitucional (art. 23, II, e art. 196), a procedência de toda e qualquer ação fundada no tema, conforme vinha ocorrendo sob esse fundamento constitucional genérico e abstrato, terminava por produzir um verdadeiro caos no orçamento público, pois

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 04/09/2024 às 19:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821845-74.2021.8.12.0110 e código kemcVp32.

> exigia a adoção de providências sem qualquer lastro de previsão financeira, impactando demasiadamente no cofres públicos e na própria condução das demais políticas pública ante a manifesta escassez de recursos.
>
> Se há medicamentos disponibilizados pelo Poder Público para o combate da moléstia, não há razão para o Judiciário interferir nas decisões legislativas e administrativas sobre a pretensa justificativa da existência do direito fundamental à vida e à saúde, afinal, as leis devem ser compreendidas dentro de um sistema interpretativo que promova a harmonia entre as normas que o compõem, sem interpretações isoladas e, no mais das vezes, desastrosas à implementação de políticas públicas"

Desta feita, o Juízo inclusive adota o parecer do NAT que se mostrou desfavorável ao pedido da parte autora como fundamento ao indeferimento do solicitado tratamento, sendo que não se observa do colhido nos autos elementos que permitam concluir que ocorrera algum tipo de ilícito/irregularidade praticado pela parte ré.

> AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME OBRIGATÓRIO - PACIENTE PORTADORA DE DEPRESSÃO - PEDIDO DE MEDICAMENTOS - PARECER DESFAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - ENUNCIADOS DO CNJ - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. Impende observar o parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT (desfavorável), bem como, o entendimento recente contido nos Enunciados sobre Direito da Saúde da I Jornada realizada em São Paulo pelo Conselho Nacional de Justiça, no caso, notadamente os de números 11, 16 e 31, ao ser apreciado o pedido formulado na peça inicial. Remessa necessária provida.
> TJMS - Remessa Necessária nº 0803643-10.2016.8.12.0018, 5ª Câmara Cível, Rel. Vladimir Abreu da Silva. j. 11.07.2017.

Ademais, não bastasse o já exposto para o não acolhimento da pretensão da exordial e onde o medicamento/tratamento solicitado não é padronizado no SUS/Rename, havendo *opções* padronizadas aptos e indicados ao tratamento da moléstia da parte autora como consta do parecer do NAT denota-se que como visto a União nem se encontra no polo passivo da lide, o que seria pertinente, quiçá a dar maiores elementos que envolvem e quanto a *não* incorporação do tratamento solicitado.

E, por sua vez, em se tratando de medicamento/tratamento requerido que não está padronizado no SUS ou Rename seria como dito *prudente* e pertinente que a União Federal participasse do feito – como ré -, haja vista que é prerrogativa do Ministério da Saúde - órgão vinculado ao ente federal -, ouvida a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), incorporar, excluir, ou alterar novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aliás, é que o dessume do art. 19-Q, da Lei 8.080/90:

> "Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS".

Ainda, anote-se que o Enunciado nº 78 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ já aponta para que *"Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS".*

Aliás, quanto a relevância e importância da União Federal em figurar no polo passivo da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 04/09/2024 às 19:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821845-74.2021.8.12.0110 e código kemcVp32.

lide em ações de tal natureza, denota-se que tal inclusive fora objeto de discussão no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF, que por meio da Tese fixada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178, em Repercussão Geral, verberou "(...) v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (Tema nº 793 do STF). E, tal fora o que restou assentado no dispositivo do voto Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão.

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO ESTADUAL ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
> STF – 1ª Turma. RE 1389742 AgR. Re. Min. CARMEN LÚCIA. Julg. 22.08.2022.

> Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.
> STF – 2ª Turma. Rel. Min. GILMAR MENDES. Reclamação 48760 AGR. Julg. 04.10.2021. Publ. 11.10.2021.

Entretanto, tem-se que a parte autora preferiu *não* litigar contra aquele que possui as condições e competência para incluir ou não o objeto/tratamento pugnado na esfera do SUS, sendo que em observância inicial de pertinência ou adequação de discussão da questão apenas contra o Réu nominado na inicial, e em não sendo o objeto dos autos padronizado na Rename e/ou SUS (conforme consta do parecer do NAT já juntado aos autos), não se mostra a princípio demonstrado de plano a obrigação da parte Estatal ora demandada na sua compra, entrega ou disponibilização à parte autora de pretensão de objeto não padronizado no SUS ou não constante da Rename *em* havendo opções no SUS.

Assim, e se há *mora* na análise de medicamento não padronizado tal não é de alçada de Ente Estadual ou Municipal, mas da União. E, ao que consta não cabe ao Ente Estadual ou Municipal fazer tal incorporação/padronização no Sistema de Saúde Pública – inclusive a dar azo a posteriores compras/licitações e consequente disponibilização de produtos - , descabendo a obrigação legal do gasto de valores públicos em aquisição de medicamento/tratamento que nem fora avaliado e muito menos acolhido pelo Poder Público e pelos órgãos de saúde competentes e a indicar a pertinência e benefícios do objeto e a dar azo a destinação do limitado erário público em tal aquisição.

Logo, anote-se por oportuno que, ao que consta, se o medicamento pugnado nem mesmo fora avaliado e aprovado por órgãos de saúde competentes a avaliar pertinência, adequação,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 04/09/2024 às 19:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821845-74.2021.8.12.0110 e código kemcVp32.

efeitos e benefícios a ser padronizada não se pode querer que ente público ora Demandado que *não* tem condição e *nem* competência para isso, por conta, passe a adquirir e ser obrigada a adquirir produtos/objetos/tratamento que nem mesmo foram avaliados e quiçá aprovados para figurarem naqueles que estão aptos e indicados para compra e distribuição pelo Poder Público, e desta feita, indicados para gastos de valores públicos, quanto mais quando há medicação padronizada pertinente para tal tratamento.

E, nesta toada, em não estando a União figurando no polo passivo da lide, bem como não se observando desta feita de plano e de forma patente a obrigação de ente Estadual e/ou Municipal diante da não padronização do objeto dos autos de disponibilizar produto/procedimento/medicamento a prévia análise e incorporação pelo Ministério da Saúde não se verifica probabilidade do direito contra a parte ora demandada, segundo a inicial como posta e sem a possibilidade de participação da União na lide.

Aliás, como dito, não se vislumbra de plano irregularidade na ausência de disponibilização por ente Estadual/Municipal de produtos não analisados, aprovados e incorporados no SUS, Rename e padronizados, sendo de responsabilidade da União tal análise. E, como já asseverou o Min. Rel. ROBERTO BARROSO em trecho da ementa da Reclamação nº 45.777-MC (DJe 11.03.2021) *"Não faz sentido, no quadro de penúria dos Estados, que caiba a eles providenciar tratamento de responsabilidade da União, para só depois pedirem ressarcimento".*

Logo, cabe, então o caminho da improcedência da pretensão deduzida na inicial.

> APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MÉRITO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO OFERECIDO PELO SUS - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas de que a parte tenha se submetido ao tratamento disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde ou que são ineficazes ou que tenha feito uso desses fármacos e que tenha havido rejeição, deverá, primeiro fazer uso dos medicamentos fornecidos pela rede pública.
> TJMS - Apelação nº 0800661-85.2015.8.12.0041, 3ª Câmara Cível, Rel. Eduardo Machado Rocha. j. 08.10.2018.
>
> RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, DA CF/88. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS E INSUMOS. PACIENTE PORTADOR DE TETRAPLEGIA ESPÁSTICA. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DOS INSUMOS E DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS E QUE TIVERAM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA NO QUE CONCERNE AO DEFERIMENTO DOS MEDICAMENTOS LYRICA, SEROQUEL XRO, AMBROXOL E LUFTAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA MÉDICA PARA O FORNECIMENTO DE TAIS FÁRMACOS QUE NÃO SÃO INDICADOS PARA O QUADRO CLÍNICO DO RECLAMANTE. PARECER DO NAT/JUD DESFAVORÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO RARIVIT, POIS HÁ ALTERNATIVA FORNECIDA PELO SUS (POLIVITAMINICO), A QUAL, INCLUSIVE, FOI PLEITEADA PELO AUTOR NESTA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA INDEFERIR O PLEITO DE RECEBIMENTO DO MEDICAMENTO MINILAX. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVOU A NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, NEM A INEFICÁCIA DO FÁRMACO ALTERNATIVO CONTIDO NA LISTA DO SUS. NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO REQUERIDO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR E TAMPOUCO A INEFICÁCIA DA ALTERNATIVA TERAPÊUTICA OFERECIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DOS MEDICAMENTOS DEFERIDOS A CADA (6) MESES. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
> Turma Recursal do Estado de Sergipe/TJSE, Recurso Inominado nº 201701009799, Rel. Isabela Sampaio Alves. j. 15.08.2018.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 04/09/2024 às 19:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821845-74.2021.8.12.0110 e código kemcVp32.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Comarca de Campo Grande
4ª Vara do Juizado da Fazenda Pública e da Saúde Pública

3. ISSO POSTO, nos termos do art. 487, I do NCPC JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão deduzida deduzida por Constância Sales Gonçalves contra Estado de Mato Grosso do Sul, já qualificados, com resolução de mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao MP. Sem custas.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivo do feito.

Diligências legais.
Campo Grande, 03 de setembro de 2024.

Daniel Della Mea Ribeiro
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

RECEBIMENTO
Em / /2024, foram-me entregues estes autos em cartório._____Escrivão/Analista

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIEL DELLA MEA RIBEIRO, liberado nos autos em 04/09/2024 às 19:27 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0821845-74.2021.8.12.0110 e código kemcVp32.